

Система органов пищеварения

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1'

Какое заболевание не является заболеванием желудочно-кишечного тракта {
~эзофагит
~энтероколит
~грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
~ахалазия кардии
=гестоз
}

Где расположена эпигастральная область {
=между двуреберной линией и правой и
левой реберными линиями
~в треугольнике образованном левой
реберной дугой, левой парастеральной
линией и двуреберной линией
~в треугольнике образованном правой
реберной дугой, правой парастеральной
линией и двуреберной линией
~в средней части живота вокруг пупка
~область сложной формы,
соответствующая проекции желудка на
переднюю брюшную стенку
}

Ранние боли это {
~боли возникающие через 1-2 дня после
начала или обострения заболевания
~боль проходящая на короткое время
после приема пищи
~очень сильные боли в левой подреберной
области
=боли возникающие через 20-30 минут
после приема пищи
~боли возникающие через 8-10 дней после
начала заболевания

}

Поздние боли это {

=боли усиливающиеся через 2-3 часа

после приема пищи

~боль проходящая на короткое время

после приема пищи

~очень сильные боли в левой подреберной области

~боли возникающие через 1-2 дня после начала заболевания

~боли возникающие через 8-10 дней после начала заболевания

}

Стереотипные боли это {

~боли усиливающиеся через 2-3 часа после приема пищи

=боли появляющиеся в определенное время дня и ночи

~симметричные боли в правой и левой подреберных областях

~боли возникающие в определенное время года

~боли возникающие после физической нагрузки

}

Панкреатит это {

~воспаление желудка

~воспаление печени

=воспаление поджелудочной железы

~воспаление 12 перстной кишки

~воспаление селезенки

}

Рвота центрального генеза наблюдается при поражении {

~желудка

~печени

~поджелудочной железы
~12 перстной кишки
=нервной системы
}

При язве 12 перстной кишки аппетит обычно {
=усилен
~ослаблен
~наблюдается анорексия
~наблюдается отвращение к мясной пище
~нет никакой закономерности
}

Тенезмами может сопровождаться {
~изжога
~отрыжка
~анорексия
=понос
~запор
}

Тянущие боли в области прямой кишки с чувством неполного опорожнения называется {
~метеоризм
~запор
~понос
=тенезмы
~отрыжка
}

Накопление газов в кишечнике называется {
=метеоризм
~запор
~понос
~тенезмы
~отрыжка
}

Запор это задержка стула более {

~12 часов
~10 суток
=2 суток
~5 суток
~1 недели
}

Кишечные кровотечения с выделением алой крови называются {
~мелена
~рвота кофейной гущей
~тенезмы
~"овечий кал"
=ни одно из перечисленного
}

Перкуторно при метеоризме звук {
~ясный
~притупленный
~тупой
=тимпанический
~ни одно из вышеперечисленного
}

Ахилия это {
=отсутствие желудочной секреции
~избыточная желудочная секреция
~отсутствие секреции поджелудочной железы
~избыточная секреция поджелудочной железы
~снижение выделения желчи
}

Ректороманоскопия это метод исследования {
~желудка и 12 перстной кишки
~печени и желчных путей
=сигмовидной и прямой кишки
~только прямой кишки
~ни одно из вышеперечисленного
}

"Печеночные ладони" это {

- ~распространенные массивные отеки
 - ~окрашивание кожи рук в желтый с зеленоватым оттенком цвет
 - ~утолщение концевых фаланг пальцев кисти
 - =покраснение кожи в области тенара и гипотенара
 - ~звездчатое расширение отдельных кожных сосудов кистей
- }

Асцит это {

- ~накопление жидкости в полости сустава
 - ~резкое истощение больного
 - ~увеличение поверхностных вен на передней брюшной стенке
 - ~большая киста брюшной полости
 - =ни одно из вышеперечисленного
- }

Симптом "головы медузы" это {

- ~увеличение живота с выпячиванием пупка
 - ~резкое истощение больного
 - =увеличение поверхностных вен на передней брюшной стенке преимущественно вокруг пупка
 - ~очень плотная деревянистая печень
 - ~ни одно из вышеперечисленного
- }

Баллотирующая пальпация печени применяется при {

- ~перитоните
 - =асците
 - ~плотной деревянистой печени
 - ~резкой болезненности печени
 - ~резком истощении больного
- }

Где находится область проекции желчного пузыря {

- ~на месте пересечения правой

парастернальной линии с линией *bicostalis*
~на месте пересечения правой
среднеключичной линии с линией
bicostalis
~на месте пересечения правой
среднеключичной линии с линией *biliaca*
=на месте пересечения правой
парастернальной линии с реберной дугой
~на месте пересечения правой передней
подмышечной линии с линией *bicostalis*
}

Дайте определение "френикус-симптома" {
~болезненность при надавливании на
место проекции желчного пузыря
~резкая болезненность при надавливании
в эпигастральной области
~ритмичное покачивание головы,
синхронное с пульсацией сонных артерий
=болезненность при надавливании на *m.*
sternocleidomastoideus у верхнего края
ключицы справа
~урежение сердечного ритма при
надавливании на глазные яблоки
}

В норме желчный пузырь пальпируется {
~почти всегда
~очень часто
~в 50% случаев
=почти никогда
~требует специальных навыков пальпации
}

Размеры печени можно определить {
при помощи
~осмотра
~пальпации
=перкуссии

~аускультации
~ни одного из вышеперечисленного
}

Размеры левой доли печени по курлову в норме {
~ $9 \pm 1-2$ см
~ $8 \pm 1-2$ см
= $7 \pm 1-2$ см
~ $6 \pm 1-2$ см
~выступает из-под реберной дуги на 3-4 см
}

Размеры правой доли печени по курлову в норме {
= $9 \pm 1-2$ см
~ $8 \pm 1-2$ см
~ $7 \pm 1-2$ см
~ $6 \pm 1-2$ см
~выступает из-под реберной дуги на 3-4 см
}

В норме перкуторно длина селезенки {
= 9 ± 2 см
~ 8 ± 2 см
~ 7 ± 2 см
~ 6 ± 2 см
~не определяется
}

В норме перкуторно ширина селезенки {
~ 9 ± 2 см
~ 8 ± 2 см
~ 7 ± 2 см
= 6 ± 2 см
~не определяется
}

Для определения положения первой точки по курлову перкутируют {
=сверху вниз по среднеключичной линии
снизу вверх по среднеключичной линии

~сверху вниз по срединной линии
~снизу вверх по срединной линии
~ни одно из вышеперечисленного
~ни одно из вышеперечисленного
}

Для определения положения третьей точки по курлову перкутируют {
~сверху вниз по среднеключичной линии
~снизу вверх по среднеключичной линии
~сверху вниз по срединной линии
~снизу вверх по срединной линии
=ни одно из вышеперечисленного
}

В норме общий белок сыворотки крови {
~18-35 г/л
~40-60 г/л
=65-85 г/л
~95-120 г/л
~18-35 мкмоль/л
}

Выберите белково-осадочную пробу, которая используется в практике до сих пор {
~проба Штанге
~бромсульфалеиновая проба
~вофвердиновая проба
=тимоловая проба
~проба Petrelli
}

Протромбиновый индекс в норме {
=100±15
~2-4 мин
~3,33-5,55 мкмоль/л
~0,407-0,503
~0-4 ед.
}

Тимоловая проба в норме {
~100±15
~2-4 мин
~3,33-5,55 мкмоль/л
~0,407-0,503
=0-5 ед.
}

При распаде гемоглобина образуется {
~прямой (конъюгированный) билирубин
=непрямой (неконъюгированный) билирубин
~общий билирубин
~уробилиноген
~стеркобилин
}

Растворим в воде, и может выделяться с мочой, окрашивая мочу в цвет пива {
=прямой (конъюгированный) билирубин
~непрямой (неконъюгированный) билирубин
~общий белок
~холестерин
~хиломикроны
}

Увеличение ферментов (асат, алат)сыворотки крови отражает {
~белково-синтезирующую функцию печени
~барьерную функцию печени
~экскреторную функцию печени
=степень повреждения (лизиса)
печеночных клеток
~пигментный обмен в печени
}

Сколько порций получают при дуоденальном зондировании с целью изучения функционирования желчного пузыря и состава желчи {
~1
~2
=3

~4
~5
}

Пузырная желчь при дуоденальном зондировании это порция {
~A
=B
~C
~D
~E
}

Положительный HBSAG наблюдается при {
~хроническом носительстве вирусного
гепатита А
=хроническом носительстве вирусного
гепатита В
~хроническом носительстве вирусного
гепатита С
~желчекаменной болезни
~механической (подпеченочной) желтухе
}

Гепатит можно назвать хроническим,если он длится более {
=6 мес.
~1 года
~2 лет
~не менее 2 обострений в год в течение 2 лет
~ни одно из вышеперечисленного
}

Выберите факторы риска гепатита {
~работа на станции переливания крови
~гемофилия
~медицинская профессия
~наркомания
=все перечисленное
}

При осмотре больного при свете электрической лампы желтуха {
~выражена более отчетливо
=не видна
~выглядит так же, как при дневном свете
~появляется синеватый оттенок, как при цианозе
~ни одно из вышеперечисленного
}

Гепатомегалия может выявляться при {
~острых гепатитах
~хронических гепатитах
~циррозах печени
~болезнях накопления
=при всех вышеперечисленных состояниях
}

Для печеночной желтухи наиболее характерно {
~повышение уровня только непрямого билирубина
~повышение уровня только прямого билирубина
=повышение уровня обеих фракций в зависимости от поражения печени
~повышение уровня каротина в крови
~повышение уровня гликозилмированного гемоглобина
}

Главная причина развития СПИДа при ВИЧ-инфекции {
~разрушение Т8 клеток
=разрушение Т4 клеток
~разрушение естественных килеров
~разрушение макрофагов
~разрушение в лимфоцитов
}

К индикаторным ферментам печени относят {
=ЛДГ, АСТ, АЛТ, альдолаза
~фруктозо-1-6-дифосфатаальдолаза

~церулоплазмин
~холинэстераза
~урокиназа
}

Для надпеченочной желтухи наиболее
характерно {

=повышение непрямого билирубина и увеличение стеркобилина в кале и моче

~повышение только непрямого билирубина
~повышение только прямого билирубина
~повышение прямого билирубина и увеличение стеркобилина в кале и моче
~появление желчных пигментов в моче
}

Синдром, отличающий цирроз печени от гепатита {

~гепатомегалия
~внепеченочные знаки
~диспепсия
~цитолитический синдром
=портальная гипертензия
}

Объясните, что такое "melena" {

~"жирный", блестящий, плохо смывающийся кал
=кал черного цвета
~обесцвеченный кал (серый)
~кал с кусочками непереваренной пищи
~черный оформленный кал
}

Оцените результаты анализа желудочного содержимого: {

Базальная секреция

Кол-во 12 Общая к-ть 16 Свободная к-ть 0

Стимуляция гистамином

Кол-во 30 Общая к-ть 44 Свободная к-ть 0

Кол-во 30 Общая к-ть 60 Свободная к-ть 0

Кол-во 21 Общая к-ть 50 Свободная к-ть 0

Кол-во 10 Общая к-ть 21 Свободная к-ть 0

Реакция на молочную кислоту
отрицательная, пепсин отсутствует
~гиперхлоргидрия
=гипохлоргидрия, гипосекреция
~ахлоргидрия
~ахилия
~норма
}

выраженное увеличение стеркобилина в кале характерно {
~для подпеченочной желтухи
=для надпеченочной (гемолитической) желтухи
~для почечно-каменной болезни
~для инфаркта почки
~для хронического нефрита
}

Внутривенная холецистография является информативным методом диагностики {
~а)расширения общего желчного протока
~б)хронического калькулезного холецистита
~в)хронического активного гепатита
=верно а) и б)
~всего перечисленного
}

Конъюгированный (связанный) билирубин образуется в клетках печени с помощью фермента {
=глюкуронилтрансферазы
~лейцинаминопептидазы
~кислой фосфатазы
~нуклеотидазы
~все перечисленное неверно
}

Лапароскопию назначают {
~при подозрении на первичный рак печени
~при подозрении на метастатический рак печени
~для уточнения причины асцита

~при подозрении на первичный и метастатический рак печени
=при всем перечисленном
}

Компьютерная томография позволяет выявить {
~опухоли брюшной полости
~кисты поджелудочной железы
~дивертикулы кишечника
~опухоли брюшной полости и кисты поджелудочной железы
=все перечисленное
}

Этиологическими факторами язвенной болезни {
являются все перечисленные, кроме
~алкоголя
~никотина
~нарушения питания
~эмоциональных стрессов
=переохлаждения
}

Для язвенной болезни характерно
~"голодные" боли в эпигастральной области
~ночные боли
~изжога
~хронический гастродуоденит
=все перечисленное
}

Подтвердить пенетрацию язвы могут все перечисленные симптомы, кроме {
=появления ночных болей
~уменьшения ответной реакции на антациды
~появления болей в спине
~усиления болей
~переход болей в боли постоянного характера
}

Больной, длительно страдающий язвенной болезнью с локализацией язвы
в желудке, обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита,

постоянные боли в эпигастральной области, похудание. в данном случае можно думать о следующем осложнении язвенной болезни {

~стенозе выходного отдела желудка

=малигнизации язвы

~пенетрации язвы

~микроворотечении из язвы

~перфорации язвы

}

Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются

{

~локализация язвы

~величина язвы

=отсутствие хронического рецидивирующего течения

~кровотечение

~частая пенетрация

}

Для асцита характерно наличие следующих симптомов {

~одышки при физической нагрузке

~снижения суточного диуреза

~увеличения веса

~ничего из перечисленного

=всё перечисленное

}

У больных с асцитом парацентез применяется {

~для диагностических целей

~для устранения одышки

~для быстрого устранения асцита

~ни для одной из перечисленных целей

=для всего перечисленного

}

Вирусы, наиболее часто приводящие к развитию хронических гепатитов и циррозов печени {

~А

=В

=С

~Д
~Е
}

Асцит при циррозе печени является следствием {
~вторичного гиперальдостеронизма
~гипоальбуминемии
~портальной гипертензии
=всего перечисленного
~ничего из перечисленного
}

При каком заболевании наблюдается снижение секреторно-кислотообразующей функции желудка {
~язвенная болезнь 12-перстной кишки
=хронический атрофический гастрит
~хронический гипертрофический гастрит
~синдром Золлингера-Эллисона
~при всех указанных формах
}

У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти постоянные боли с иррадиацией в спину. аппетит и масса тела не изменились. такое осложнение можно предположить {
~стеноз привратника
=пенетрация
~малигнизация
~перфорация
~демпинг-синдром
}

Внутривенная холеграфия является информативным методом для диагностики {
~расширения общего желчного протока
~хронического калькулезного холецистита
~хронического активного гепатита
=ничего из перечисленного
~для всего перечисленного
}

Ферменты - маркеры холестаза: {

~АЛТ

~АСТ

=щелочная фосфатаза

~ЛДГ

~креатинфосфокиназа

}

В диагностике цирроза печени решающим является {

~уровень альбуминов

~уровень билирубина

~тимоловая проба

~уровень трансаминаз

=ни один из перечисленных тестов

}

Причиной механической желтухи является {

~холедохолитиаз

~стриктура фатерова соска

~рак головки поджелудочной железы

~ничего из перечисленного

=все вышеназванное

}

Увеличение активности щелочной
фосфатазы наблюдается {

~при внутрипеченочном холестазе

~при вирусном гепатите

~при подпеченочном холестазе

~при гемолитической анемии

=при любом холестазе

}

Из перечисленных признаков о внутрипеченочном холестазе свидетельствует {

~увеличение уровня гамма-глобулинов

~снижение уровня липопротеидов

=повышение щелочной фосфатазы

~повышение уровня АСТ и АЛТ
~снижение уровня кислой фосфатазы
}

К вам на прием обратился больной с жалобами на боли в эпигастрии, появляющиеся через 1,5-2 часа после еды и натощак. на наличие какой патологии

предположительно указывает этот симптом {

~хронический гастрит
~язвенная болезнь желудка
=язвенная болезнь 12-перстной кишки
~панкреатит
~холецистит
}

Реакция кала на скрытую кровь может быть положительной {

~при микрокровотечениях из язвы
двенадцатиперстной кишки или кишечника
~при микрокровотечениях из опухолей
желудочно-кишечного тракта
~при микрокровотечениях из язвы желудка
~при употреблении мяса в пищу
=при всем перечисленном
}

Каков характер болей при язвенной болезни 12-перстной кишки {

~тупая, давящая боль в эпигастрии, усиливающаяся при приеме пищи
~схваткообразные ноющие боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо при приеме жирной пищи
~постоянная тупая боль, не связанная с приемом пищи
=боли в эпигастрии, возникающие натощак и через 2-3 часа после еды, уменьшающиеся сразу после еды («голодные»)
~боли через 30 минут после еды
}

Главным местом метаболизма алкоголя в организме является {

~жировая ткань
~почки
=печень

~головной мозг
~желудочно-кишечный тракт
}

Для язвенной болезни характерно
~"голодные" боли в эпигастральной области
~ночные боли
~изжога
~запоры
=все перечисленное
}

У больного, страдающего язвенной болезнью желудка, в период очередного обострения появились жалобы на отрыжку "тухлым яйцом", рвоту принятой накануне пищи. какое осложнение возникло у больного {
~пенетрация
~перфорация
~кровотечение
=стеноз привратника
~малигнизация
}

Женщина 35 лет предъявляет жалобы на кожный зуд. больна в течение 3 лет. При обследовании выявлена плотная увеличенная печень, выступающая из-под края реберной дуги на 10 см. билирубин - 96 мкмоль/л, прямой - 80 мкмоль/л, щелочная фосфатаза - 400 ед., алт - 86 ед. предположительный диагноз {
~портальный цирроз печени
~хронический активный гепатит
~гемолитическая желтуха
=билиарный цирроз печени
~острый вирусный гепатит
}

Какая жалоба не характерна для заболеваний пищевода {
~Дисфагия
~Рвота
=Поносы
~Кровотечения

~Изжога

}

При детализации жалоб на боли в подложечной области необходимо уточнение: {

~локализации

~ночной или голодный характер

~облегчения состояния после приёма щелочей (соды)

~периодичности болей

=всего перечисленного

}

Какие утверждения в отношении плевральной пункции не верны {

~Плевральную пункцию проводят с
диагностической и лечебной целями

~Прокол грудной стенки производят для
введения ЛС

~Пункцию проводят по задней
подмышечной линии в
по верхнему краю нижележащего ребра

~Плевральная пункция показана
при экссудативном плеврите

=Плевральная пункция показана при
сухом плеврите

}

Появление "мелены" характерно для {

=кровотечение из высоких отделов ЖКТ

~длительного приема препаратов висмута

~кровотечения из сигмовидной кишки

~дизентерии

~бродильной диспепсии

}

Быстро увеличивающаяся и каменисто-плотная печень выявляется при {

~хроническом алкогольном гепатите

~хроническом вирусном гепатите

~при прогрессировании недостаточности
кровообращения
~гепатозе
=первичном раке печени
}

Отвращение к мясным блюдам свойственно больным {
~хроническим колитом
~хроническим гастритом
~язвенной болезнью желудка
~язвенной болезнью 12-перстной кишки
=раком желудка
}

Появление телеангиоэктазий характерно для {
~вирусного гепатита
~хронического холецистита
=цирроза печени
~метастатического поражения легких
~желчекаменной болезни
}

Рвота пищей, съеденной накануне, бывает при {
~хроническом гастрите
~язвенной болезни желудка
~раке кардиального отдела желудка
=стенозе привратника
~язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
}

Ксантелазмы определяются при {
~хроническом панкреатите
~митральном стенозе
~эмфиземе легких
=циррозе печени
~остром гломерулонефрите
}

При осмотре больного выявлена гиперемия ладоней, языка, "сосудистые

звездочки". заподозрен {
~хронический холецистит
~эхинококк печени
~алкогольный гепатоз
=Цирроз печени
~язвенная болезнь желудка
}

Полусогнутое положение сидя с прижатыми к болезненной области живота руками занимают больные с {
=обострением язвенной болезни
~острым аппендицитом
~раком поджелудочной железы
~диафрагмальном плевритом
~перитонитом
}

"Кинжальная" боль в эпигастральной области характерна для следующего осложнения язвенной болезни {
=перфорация
~пенетрация
~малигнизация
~стеноза
~кровотечение
}

Характерным признаком асцита при осмотре является {
=увеличенный в объеме живот с выбухающим пупком
~увеличенный в объеме живот с глубоким, втянутым пупком
~венозный рисунок на боковых участках живота
~отеки нижних конечностей
~"печеночные" ладони
}

Синдром мальабсорбции возникает при {
~остром гастрите
=резекции участка тонкой кишки

~резекции сигмовидной кишки

~язве 12-перстной кишки

~язве желудка

}

При глубокой пальпации слепой кишки кожная складка делается по направлению к {

~ребню подвздошной кости

=пупку

~мечевидному отростку

~правому подреберью

~левому подреберью

}

При пальпации восходящего отдела толстой кишки кожная складка делается по направлению к{

~ребню подвздошной кости

=пупку

~мечевидному отростку

~правому подреберью

~левому подреберью

}

Стеаторея – это присутствие в кале большого количества{

~крахмала

=нейтрального жира

~клетчатки

~мышечных волокон

}

Амилорея – это присутствие в кале большого количества{

=крахмала

~нейтрального жира

~клетчатки

~мышечных волокон

}

Спланхноптоз – это{

=опущение внутренних органов

~уменьшение размеров внутренних органов

~увеличение размеров внутренних органов

~нарушения эмбрионального развития внутренних органов

}

Боли при язве 12-перстной кишки чаще всего локализуются в эпигастральной области{

~у мечевидного отростка по срединной линии

~слева от срединной линии

=справа от срединной линии

}

При язве пилорического отдела желудка боли чаще всего локализуются в эпигастральной области{

~у мечевидного отростка

=справа от срединной линии

~слева от срединной линии

~в области левого подреберья

}

При язве кардиального отдела желудка боли чаще всего локализуются в эпигастральной области{

=у мечевидного отростка

~в области пупка

~справа от срединной линии

~в области правого подреберья

}

Назовите заболевание, при котором сравнительно часто натошак выявляется шум плеска в желудке. {

~острый гастрит.

~хронический атрофический гастрит.

~язва желудка.

~рак кардиального отдела желудка.

=язва 12-перстной кишки.

}

Может ли наблюдаться при язве резкое напряжение мышц передней брюшной стенки и положительный симптом раздражения брюшины? {

~нет.

~если «да», то в фазе обострения заболевания.

~да, при кровотечении.

~да, при малигнизации.

=да, при перфорации.

}

При каком осложнении язвы выявляется поздний «шум плеска» и усиленная перистальтика в эпигастрии? {

~при кровотечении.

~при прободении.

~при пенетрации.

=при стенозе привратника.

~при малигнизации.

}

При каком заболевании выявляется рентгенологический симптом «ниши»? {

~при остром гастрите.

~при хроническом гастрите.

= при язве.

~при раке желудка

}

При каком заболевании выявляется рентгенологический симптом «дефект наполнения»? {

~при остром гастрите.

~при хроническом гастрите.

=при раке желудка.

~при язве желудка.

~при язве 12-перстной кишки

}

Что в анализе кала характерно для кровотечения из нижних отделов толстого кишечника? {

~кал темно-коричневого цвета.

=примесь алой крови в кале.

~черный дегтеобразный стул.

~большое количество лейкоцитов.

}

Каким из перечисленных способов исследования кала лучше всего выявляется амилаорея? {

~макроскопическим.

~реакцией Грегерсена.

~микроскопическим в нативном препарате.

=микроскопическим в препарате окрашенном раствором Люголя.

~микроскопическим в препарате окрашенном суданом III.

}

Каким из перечисленных способов исследования кала лучше всего выявляется нейтральный жир? {

~микроскопическим в нативном препарате.

~микроскопическим в препарате окрашенном раствором Люголя.

=микроскопическим в препарате окрашенном суданом III.

~химическим (реакция Грегерсена).

}

Какой метод исследования позволяет наиболее точно установить диагноз «язва желудка»? {

~расспрос.

~поверхностная пальпация живота.

~глубокая пальпация живота.

~исследование секреторной функции желудка.

=фиброгастродуоденоскопия.

}

Какой из перечисленных рентгенологических признаков относится к прямым признакам язвы? {

~усиленная перистальтика желудка или 12-перстной кишки.

~обрыв перистальтической волны.

=симптом «ниши».

~дефект наполнения.

}

Какой из приведенных методов исследования позволяет наиболее точно диагностировать хронический гастрит? {

~расспрос.

~пальпация живота.

~исследование секреторной функции желудка.

~рентгенологическое исследование желудка.

=фиброгастроскопия с биопсией слизистой.

}

Диагностические признаки рака желудка могут быть выявлены при{

~расспросе

~аускультации живота

~рентгеноскопии (графии) желудка

=фиброгастроскопии с биопсией

~колоноскопии

}

Какой из перечисленных методов исследования позволяет наиболее точно установить диагноз рака желудка? {

~расспрос.

~пальпация живота.

~исследование секреторной функции желудка.

=фиброгастроскопия с биопсией.

}

Назовите современный метод оценки кислотообразующей функции желудка.
{

=рН-метрический метод.

~метод исследования желудочного сока.

~эндоскопический метод.

~рентгенологический метод.

}

При какой желтухе одновременно повышается свободный и связанный билирубин в крови? {

~надпеченочной.

=печеночной.

~подпеченочной.

~при всех.

}

Каковы особенности метаболизма уробилиногена? {

~образуется из холестерина.

=образуется из билирубина.

~образуется из стеркобилиногена.

~образуется из липопротеидов

}

При какой желтухе выявляется одновременно билирубин и уробилиноиды в моче? {

=при печеночной.

~при подпеченочной.

~при надпеченочной.

~при всех.

}

При какой желтухе повышается стеркобилиноген в кале? {

=при печеночной.

~при подпеченочной.

~при надпеченочной.

~при всех.

}

При какой желтухе повышаются свободный билирубин в крови, уробилиноиды в моче и стеркобилиноген в кале? {

~при печеночной.

~при подпеченочной.

=при надпеченочной.

~при всех.

}

При какой желтухе повышается билирубин в крови, который выводится с мочой, отсутствуют уробилиноиды в моче и стеркобилиноген в кале? {

~при печеночной.

~при подпеченочной.

=при надпеченочной.

~при всех.

}

При какой желтухе повышаются свободный и связанный билирубин в крови; выявляются билирубин и уробилиноиды в моче; уменьшается стеркобилиноген в кале? {

=при печеночной.

~при подпеченочной.

~при надпеченочной.

~при всех.

}

Какой из перечисленных показателей не соответствует изменениям пигментного обмена при гемолитической желтухе? {

~общий билирубин в крови повышен.

~билирубин повышен.

=билирубин в моче – реакция резко положительная.

~уробилин в моче – реакция положительная.

~стеркобилиноген в кале – реакция резко положительная.

}

Что характерно для «ложной» желтухи? {

~повышен общий билирубин в крови.

~желтушность кожи и склер глаз.

=желтушность только кожи.

~общий билирубин в крови в норме.

~желтушность только склер ладоней.

}

Содержится ли при механической (подпеченочной) желтухе в моче билирубин? {

~не содержится.

=содержится только прямой (связанный) билирубин.

~содержится только непрямой (свободный) билирубин.

~содержатся обе фракции билирубина.

}

Для какой желтухи характерны эти результаты исследования? {

В крови: общий билирубин 109,5 мкмоль/л; прямой билирубин 92,4 мкмоль/л; непрямой билирубин 17,1 мкмоль/л. В моче: реакция на билирубины положительная, уробилина нет. Кал: стеркобилин отсутствует.

~для гемолитической (надпеченочная).

~для паренхиматозной (печеночная).

=для механической (подпеченочная).

~для всех видов желтух.

~Для «ложной» желтухи.

}

Из чего образуется стеркобилиноген? {

=Из билирубина.

~Из уробилина.

~Из стеркобилина.

~Непосредственно из эритроцитов.

Какая фракция билирубина при ее повышении в крови выделяется с мочой? {

=Связанный билирубин (прямой).

~Свободный билирубин (непрямой).

~Общий билирубин.

~Все фракции.

}

Спленомегалия – это{

=Увеличение селезенки

~Увеличение печени

~Уменьшение размеров селезенки

~Уменьшение печени

}

Для каких из перечисленных заболеваний характерен синдром холестаза?

~хронический холецистит. {

~портальный цирроз печени.

=первичный билиарный цирроз печени.

=желчнокаменная болезнь (обтурация общего желчного протока).

~хронический персистирующий гепатит.

}

Наиболее частая причина ладонной эритемы? {

~гипофункция щитовидной железы.

~хронический бронхит.

~острая ревматическая лихорадка.

=цирроз печени.

~хронический холецистит.

}

Отеки при циррозах печени могут быть обусловлены{

~повышением содержания белка в сыворотке крови

~повышением гиалуронидазной активности в сыворотке крови

=снижением содержания альбуминов в крови

~снижением количества альдостерона в сыворотке крови

~повышением содержания билирубина в крови

}

Портальная гипертензия – это{

=повышение давления в V.portae

~повышение артериального давления

~повышение центрального венозного давления

~повышение внутричерепного давления

}

Сколько точек при определении размеров печени по М.Г. Курлову Вы знаете?

{

~3.

~4.

=5.

~6.

~7.

}

Первая точка по Курлову соответствует{

~нижней границе абсолютной печеночной тупости по правой срединно-ключичной линии

=верхней границе абсолютной печеночной тупости по правой срединно-ключичной линии

~нижней границе абсолютной печеночной тупости по правой грудинной линии

~верхней границе абсолютной печеночной тупости по правой грудинной линии

}

Четвертая точка по Курлову соответствует{

=нижней границе печени по передней срединной линии

~нижней границе печени по левой грудинной линии

~нижней границе печени по правой грудинной линии

~верхней границе печени по правой грудинной линии

}

Что характерно для пальпации живота при хроническом гепатите? {

~боли в зоне желчного пузыря.

~боли в левом подреберье.

=гепатомегалия.

~нормальные размеры печени.

~спленомегалия при нормальных размерах печени.

}

Перечислите данные осмотра пациентов с циррозом печени. {

=желтушность кожи.

~гиперемия лица.

~ «малиновый язык».

~ «сосудистые звездочки».

~ксантепазмы.

}

Основной жалобой пациентов с первичным билиарным циррозом является{

~отечность лица

~боли в правом подреберье

=зуд кожных покровов

~полиурия

~ахолия

}

После приема бензойно-кислого натрия, гиппуровую кислоту определяют в моче, собранной{

~через 1 час

~в течение 2 часов

=в течение 4 часов

}

Как чаще изменяется уровень протромбина при заболеваниях печени? {

~повышается.

=понижается.

~не изменяется.

~все ответы верные.

}

Что характерно для синдрома «цитолиза гепатоцитов»? {

~положительная сулемовая проба.

=повышение активности трансаминаз крови (AST, ALT).

~понижение активности трансаминаз крови (AST, ALT).

~снижение альбумино/глобулинового коэффициента.

~повышение содержания в крови протромбина.

}

Для какого синдрома характерно уменьшение альбуминов, увеличение глобулинов (альфа и гамма) и иммуноглобулинов в крови? {

~для синдрома холестаза.

=для синдрома воспаления гепатоцитов.

~для синдрома цитолиза гепатоцитов.

~для синдрома печеночно-клеточной недостаточности.

~для портальной гипертензии.

}

Активность какого фермента повышается при синдроме холестаза? {

~АсАТ.

~АлАТ.

~щелочной фосфатазы.

=лактатдегидрогеназы.

~амилазы.

}

Активность какого фермента в крови снижается при синдроме печечно-клеточной недостаточности? {

~аминотрансферазы аспарагиновой (AST).

~аминотрансферазы аланиновой (ALT).

~щелочной фосфатазы.

~лактатдегидрогеназы.

=холинэстеразы сывороточной.

}

Какая проба проводится для исследования углеводной функции печени? {

~с нагрузкой глюкозой.

~с нагрузкой фруктозой.

=с нагрузкой галактозой.

~Квика-Пытеля.

~бромсульфалеиновая.

}

Блок В (25%)_

ТЗ Форма 2²

Выберите два наименее информативных метода обследования при заболеваниях желудка и 12 перстной кишки {

~%-33.33333% осмотр

~%-33.33333% пальпация

~%50% перкуссия

~%50% аускультация

~%-33.33333% лабораторные данные

}

Для боли при язвенной болезни 12 - перстной кишки характерно {

~%50% появление через 1,5-2 часа после еды

~%-33.33333% появление через 15 минут после еды
~%50% облегчение боли после рвоты
~%-33.33333% усиление боли сразу после приема пищи
~%-33.33333% появление боли после приема жирной
пищи
}

Для изучения секреторной функции желудка используются {
~%-33.33333% йодокалиевая проба
~%-33.33333% проба с d ксилозой
~%50% гистаминовые тесты
~%50% определение уропепсиногена в моче
~%-33.33333% каротиновый тест
}

Для определения всасывательной функции кишечника используются
~%33.33333% йодокалиевая проба
~%33.33333% проба с d ксилозой
~%-50% гистаминовый тест Кея
~%-50% определение уропепсиногена в моче
~%33.33333% каротиновый тест
}

Выберите основные жалобы больных
с заболеваниями печени {
~%-33.33333% боли в эпигастральной области
~%-33.33333% боли в правой подвздошной области
~%50% чувство тяжести в правом подреберье
~%-33.33333% кахексия
~%50% появление желтухи
}

Острые, сильные, схваткообразные боли в правом подреберье характерны
для {
~%50% острого холецистита
~%-33.33333% острого гепатита
~%50% желчной колики на основе желчекаменной болезни
~%-33.33333% цирроза печени тяжелой степени
~%-33.33333% инфаркта миокарда

}
Как по другому называется билирубин глюкуронид {
~%50% прямой
~%-33.33333% непрямой
~%-33.33333% свободный
~%50% связанный
~%-33.33333% неконъюгированный
}

Охарактеризуйте непрямой билирубин {
~%50% образуется в крови при распаде гемоглобина
~%-33.33333% образуется после прохождения через
печень, выделяется с желчью
~%-33.33333% растворим в воде, в норме в крови
небольшое количество (менее 25 %),
может выделяться с мочой
~%50% не растворим в воде, не выделяется с
мочой, связан с альбуминами крови, в
крови 2/3 от общего
~%-33.33333% увеличивается при механической желтухе
}

Охарактеризуйте прямой билирубин {
~%-50% образуется при распаде гемоглобина
~%33.33333% растворим в воде, в норме в крови
небольшое количество (менее 25 %),
может выделяться с мочой
~%33.33333% образуется после прохождения через
печень, выделяется с желчью
~%33.33333% увеличивается при механической
желтухе
~%-50% не растворим в воде, не выделяется с
мочой, связан с альбуминами крови
}

К основным методам, позволяющим
верифицировать диагноз хронического
гастрита, относятся {
~%-50% перкуторное исследование желудка

~%50% пальпаторное исследование желудка
~%33.33333% гастроскопия
~%33.33333% морфологическое исследование
слизистой оболочки желудка
~%33.33333% выявление *Helicobacter pylori*
}

Ведущими факторами в возникновении язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки являются {
~%33.33333% гиперсекреция соляной кислоты
~%33.33333% дуоденит
~%50% заболевания желчного пузыря
~%33.33333% хеликобактерная инфекция
~%50% заболеваний печени
}

Что из перечисленного может подтвердить пенетрацию язвы {
~%50% приобретение постоянного характера болей
~%33.33333% ранний характер болей
~%33.33333% появление болей в ночное время
~%50% усиление болей и изменение их характерного ритма
~%33.33333% мелена
}

Отметьте методы изучения всасывательной функции кишечника {
~%33.33333% гастроскопия
~%33.33333% изучение желудочного сока
~%50% каротиновый тест
~%50% проба с д-ксилозой
~%33.33333% бромсульфалеиновая проба
}

Асцит может быть следствием {
~%33.33333% цирроза печени
~%50% хронического гепатита
~%33.33333% рака придатков матки
~%33.33333% полисерозита
~%50% хронического холецистита
}

При наличии у больного симптомов явного желудочно-кишечного кровотечения ему следует произвести {

~%-33.33333% обзорную рентгенографию органов

грудной и брюшной полости

~%-33.33333% рентгенографию желудочно-кишечного тракта с бариевой взвесью

~%50% эзофагогастродуоденоскопию

~%50% колоноскопию

~%-33.33333% провести анализ кала на скрытую кровь

}

Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является {

~%50% рвота съеденной накануне пищей

~%-33.33333% урчание в животе

~%-33.33333% резонанс под пространством Траубе

~%50% шум плеска через 3-4 часа после приема пищи

~%-33.33333% видимая перистальтика

}

Вирусы, наиболее часто приводящие к развитию хронических гепатитов и циррозов печени {

~%-33.33333% А

~%50% В

~%50% С

~%-33.33333% Д

~%-33.33333% Е

}

Характеристика болей при панкреатите {

~%-33.33333% чаще локализуются в верхней половине живота

~%50% чаще локализуются в левом подреберье

~%50% носят опоясывающий характер, усиливаются в положении на спине

~%-33.33333% чаще локализуются в правом подреберье

~%-33.33333% могут иррадиировать в загрудинную область

}

Хроническая алкогольная интоксикация приводит {

~%50% к жировой дистрофии

~%-33.33333% к холестатическому гепатиту
~%50% к циррозу печени
~%-33.33333% ко всему перечисленному
~%-33.33333% ни к чему из перечисленного
}

Выберите признаки, отличающие гепатит от цирроза {
~%50% отсутствие портальной гипертензии
~%-33.33333% сосудистые звездочки
~%-33.33333% гинекомастия
~%50% отсутствие признаков анастомозирования вен
~%-33.33333% длительность до 6 месяцев
}

Печень - единственное место синтеза {
~%50% альбуминов
~%50% протромбина
~%-50% гамма-глобулинов
~%-50% ничего из вышеперечисленного
}

Выберите правильные утверждения в отношении свободной жидкости в брюшной полости {
~%33.33333% перкуссию проводят от пупка по направлению к боковым отделам живота
при положении больного на спине
~%33.33333% в вертикальном положении больного тупой звук определяется в низу живота
~%-50% для определения больших количеств жидкости рекомендуется перкуссия в коленно-локтевом положении больного
~%-50% малое количество жидкости обнаруживается с помощью симптом флюктуации
~%33.33333% в положении на боку над верхней половиной живота тупой звук сменяется тимпаническим
}

Какие состояния необходимо исключать при наличии скрытой крови в кале {
~%33.33333% язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения

~%33.33333% опухоль толстой кишки
~%-50% дисбактериоз
~%33.33333% цирроз печени
~%-50% рефлюкс-эзофагит
}

Какие факторы могут выступать причинами запоров {
~%33.33333% опухоли
~%33.33333% малоподвижный образ жизни
~%33.33333% прием малого количества пищи или ее сильное переваривание
~%-50% избыточное содержание растительной клетчатки в пище
~%-50% синдром Золлингера-Эллисона
}

Какие факторы относят к факторам риска заболеваний печени {
~%33.33333% переливание крови
~%-50% курение
~%33.33333% злоупотребление алкоголем
~%33.33333% внутривенное введение наркотиков
~%-50% переохлаждение
}

Какие жалобы предъявляют больные с циррозом печени {
~%33.33333% увеличение живота в объёме
~%33.33333% кровотечения изо-рта
~%-50% кровохарканье
~%33.33333% выраженная слабость
~%-50% диарея
}

Что позволяет выявить перкуссия живота {
~%33.33333% громкий тимпанический звук над желудком, кишечником
~%33.33333% свободную или осумкованную жидкость в брюшной
полости
~%-50% перистальтику кишечника
~%-50% шум трения брюшины
~%33.33333% увеличение печени, селезенки
}

Какие лабораторные признаки могут указывать на поражение печени {
~%50% увеличение активности АЛТ и АСТ
~%-33.33333% гиперкалиемия
~%50% гипербилирубинемия
~%-33.33333% отрицательная тимоловая проба
~%-33.33333% снижение содержания тромбоцитов
}

Повышение каких ферментов является маркёром цитолиза гепатоцитов {
~%50% АЛТ
~%-33.33333% МВ-фракция КФК
~%50% АСТ
~%-33.33333% амилаза
~%-33.33333% холинэстераза
}

Какие инструментальные исследования наиболее ценны при подозрении на цирроз печени {
~%33.33333% ФГДС (фиброгастродуоденоскопия)
~%33.33333% УЗИ брюшной полости
~%-50% ирригоскопия
~%33.33333% биопсия печени
~%-50% сцинтиграфия печени
}

Что имеет значение в развитии асцита при заболеваниях печени {
~%33.33333% портальная гипертензия
~%-50% нарушение свёртывания крови
~%33.33333% активация ренин-альдостероновой системы
~%-50% гипербилирубинемия
~%33.33333% гипоальбуминемия
}

Диарея – это {

~%50% стул 3 раза в сутки
~%-50% стул 2 раза в сутки
~%50% стул 4 раза в сутки

~%-50% стул 1 раз в сутки

}

Опишите боль при остром панкреатите. {

~%-50% боль неинтенсивная.

~%33.33333% боль интенсивная.

~%-50% боль локализуется в правом подреберьи.

~%33.33333% боль локализуется в левом подреберьи.

~%33.33333% боль носит опоясывающий характер.

}

Рвота может быть симптомом {

~%33.33333% заболеваний центральной нервной системы

~%33.33333% заболеваний желудка

~%-50% заболеваний органов дыхания

~%33.33333% интоксикации организма

~%-50% заболеваний органов кровообращения

}

Назовите характерные особенности рвоты при заболеваниях желудка. {

~%33.33333% возникает на высоте боли, локализованной в подложечной области.

~%-50% многократная, не приносит облегчения.

~%33.33333% приносит облегчение.

~%-50% сочетается с приступообразными болями в правом подреберье.

~%33.33333% сочетается с другими симптомами желудочной диспепсии.

}

Назовите заболевания, при которых может быть рвота содержимым цвета «кофейной гущи». {

~%-50% простой острый гастрит.

~%33.33333% язва желудка.

~%33.33333% эрозивный гастрит.

~%-50% хронический гастрит.

~%33.33333% рак желудка.

}

Назовите заболевания, при которых часто бывает диарея. {

~%-50% язва 12-перстной кишки.

~%33.33333% дисбактериоз кишечника.

~%33.33333% хронический колит.

~%-50% гипофункция щитовидной железы.

~%33.33333% пищевая аллергия.

}

Черный дегтеобразный стул (melena) может быть симптомом . {

~%-33.33333% простого острого гастрита

~%50% коррозивного гастрита

~%50% язвы желудка и 12-перстной кишки

~%-33.33333% хронического гастрита

~%-33.33333% рака прямой кишки

}

Для язвы 12-перстной кишки характерно возникновение боли . {

~%-50% сразу же после приема пищи

~%-50% через 15-30 минут после приема пищи

~%50% через 2-3 часа после приема пищи

~%50% ночью, на «голодный желудок»

}

Какие диспепсические жалобы часто бывают при язве 12-перстной кишки? {

~%-33.33333% тошнота.

~%50% рвота на высоте болей.

~%50% изжога.

~%-33.33333% диарея.

~%-33.33333% горечь во рту.

}

При язве кардиального отдела желудка боль может иррадиировать . {

~%50% в область сердца

~%50% в грудной отдел позвоночника

~%-50% в область правого подреберья

~%-50% в область пупка

}

Какие диспепсические жалобы бывают сравнительно часто при язве желудка? {

~%-33.33333% тошнота.

~%50% рвота на высоте болей.

~%50% изжога.

~%-33.33333% отрыжка воздухом.

~%-33.33333% диарея.

}

В каких случаях при язве снижается секреторная и кислотообразующая функция желудка? {

~%50% при язве субкардиального отдела желудка.

~%-50% при язве пилорического отдела желудка.

~%50% при язве двенадцатиперстной кишки.

~%50% при малигнизации.

}

Укажите особенности хронического атрофического гастрита. {

~%50% поражение дна и тела желудка.

~%-33.33333% поражение антрального отдела желудка.

~%50% атрофия слизистой желудка.

~%-33.33333% эрозии слизистой.

~%-33.33333% выраженное воспаление слизистой.

}

Синдром желудочной диспепсии включает в себя .{

~%50% боль в эпигастриальной области

~%-50% запор

~%50% чувство переполнения в подложечной области после еды

~%-50% диарею

}

При кровопотере наблюдается. {

~%-50% брадикардия

~%50% тахикардия

~%-50% гипертензия

~%50% гипотензия

}

Назовите симптомы желудочного кровотечения. {

~%50% тахикардия.

~%-50% гипертензия.

~%50% мелена.

~%-50% цианоз.

}

Рентгеноскопия (графия) желудка выявляет диагностические признаки. {

~%33.33333% язвы желудка

~%33.33333% язвы 12-перстной кишки

~%-50% острого гастрита

~%-50% хронического гастрита

~%33.33333% рака желудка

}

Биопсия слизистой желудка является методом исследования, уточняющим диагноз . {

~%-50% острого гастрита

~%33.33333% хронического гастрита

~%33.33333% рака желудка

~%33.33333% полипов желудка

~%-50% острого гастродуоденита

}

При помощи ректороманоскопии можно выявить заболевания . {

~%-33.33333% восходящей и нисходящей ободочной кишки

~%-33.33333% слепой кишки

~%-33.33333% поперечно-ободочной кишки

~%50% сигмовидной кишки

~%50% прямой кишки

}

Какие из перечисленных элементов в анализе кала подтверждают снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы? {

~%-50% большое количество эритроцитов и лейкоцитов.

~%-50% большое количество переваренной растительной клетчатки.

~%33.33333% креаторея +++.

~%33.33333% стеаторея +++.

~%33.33333% амилорея +++.

}

Какие из перечисленных показателей в анализе кала характерны для обтурации общего желчного протока? {

~%-50% кал черного цвета.

~%33.33333% кал цвета белой глины (ахоличный).

~%-50% кал золотисто-желтого цвета.

~%33.33333% отсутствие стеркобилиногена.

~%33.33333% стеаторея ++++.

}

Какие из перечисленных показателей в анализе кала характерны для кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта? {

~%-33.33333% цвет кала золотисто-желтый.

~%-33.33333% примесь алой крови в кале.

~%50% черный дегтеобразный стул (melena).

~%50% реакция Грегерсена ++++.

~%-33.33333% большое количество эритроцитов.

}

Что из ниже перечисленного выявляется в анализе кала в большом количестве при резком угнетении желудочной секреции? {

~%-50% стеаторея.

~%-50% амилорея.

~%50% соединительнотканые волокна.

~%50% мышечные волокна.

}

Каким из перечисленных способов можно выявить скрытую кровь в кале?

Макроскопическим. {

~%50% микроскопическим в нативном препарате.

~%-50% микроскопическим с окраской суданом III.

~%-50% микроскопическим с окраской раствором Люголя.

~%50% химическим (реакция Грегерсена).

}

Назовите способы выявления *Helicobacter pylori*. {

~%50% бактериологический.

~%50% морфологический.

~%-33.33333% макроскопический.

~%-33.33333% провокационный.

~%-33.33333% микроскопический.

}

Для верификации диагноза ГЭРБ используется {

~%-33.33333% ультразвуковое исследование

~%50% ФГДС

~%50% pH-метрии

~%-33.33333% контрастная рентгенография

~%-33.33333% пальпация

}

Какие изменения в анализе крови характерны для острого панкреатита? {

~%-33.33333% Увеличение активности щелочной фосфатазы.

~%50% увеличение активности амилазы.

~%-33.33333% увеличение активности аминотрансфераз.

~%33.33333% увеличение активности лактатдегидрогеназы.

~%50% увеличение активности липазы.

}

Диагностические признаки острого гастрита могут быть выявлены при {

~%33.33333% расспросе пациента

~%33.33333% пальпации живота

~%-50% исследовании секреторной функции желудка

~%-50% рентгеноскопии и графии желудка

~%33.33333% фиброгастроскопии

}

При каких желтухах повышается свободный (непрямой) билирубин в крови?

{

~%50% надпеченочной (гемолитической)

~%-50% подпеченочной (механической)

~%50% печеночной

~%-50% при всех

}

При каких желтухах повышается связанный (прямой) билирубин в крови? {

~%-50% надпеченочной

~%50% печеночной

~%50% подпеченочной

~%-50% при всех

}

При каких желтухах выявляются уробилиноиды в моче? {

~%50% печеночной.

~%-50% при подпеченочной.

~%50% при надпеченочной.

~%-50% при всех.

}

У пациента после приступа печеночной колики произошла полная закупорка общего желчного протока. Какие изменения характерны для этого состояния? {

~%50% в крови повышен прямой (связанный) билирубин.

~%-33.33333% в крови повышен непрямой (свободный) билирубин.

~%-33.33333% в моче повышено содержание уробилиновых тел.

~%50% в моче уробилиновых тел нет.

~%-33.33333% изменений показателей в крови и моче нет.

}

Для каких из перечисленных заболеваний характерен синдром холестаза?

~%-33.33333% хронический холецистит. {

~%-33.33333% портальный цирроз печени.

~%50% первичный билиарный цирроз печени.

~%50% желчнокаменная болезнь (обтурация общего желчного протока).

~%-33.33333% хронический персистирующий гепатит.

}

При каких заболеваниях наиболее вероятно нарушение экскреторной функции печени? {

~%-33.33333% при хроническом холецистите.

~%-33.33333% при желчнокаменной болезни.

~%-33.33333% при хроническом персистирующем гепатите.

~%50% при хроническом активном гепатите.

~%50% при циррозе печени.

}

Что включает клиника цирроза печени? {

~%50% астеновегетативный синдром.

~%50% диспепсический синдром.

~%-50% синдром артериальной гипертензии.

~%-50% выраженный болевой синдром.

}

Перечислите данные осмотра пациентов с циррозом печени. {

~%-33.33333% цианоз кожи.

~%50% «печеночные ладони».

~%50% гингивит.

~%-33.33333% отечность лица.

~%-33.33333% экзофтальм.

}

Какие показатели липидного обмена сравнительно часто исследуют в крови для диагностики функционального состояния печени? {

~%50% холестерин.

~%-50% пребеталипопротеиды.

~%50% β -липопротеиды.

~%-50% триглицериды.

}

По результатам белково-осадочных проб можно выявить .{

~%-33.33333% холестаза

~%50% воспаление гепатоцитов

~%50% диспротеинемию

~%-33.33333% нарушение антитоксической функции печени

~%-33.33333% нарушение выделительной функции печени

}

При каких заболеваниях гепато-билиарной системы повышается в крови количество холестерина и липопротеидов? {

~%-33.33333% при хроническом холецистите.

~%50% при желчнокаменной болезни (обтурации общего желчного протока).

~%50% при первичном билиарном циррозе печени.

~%-33.33333% при хроническом персистирующем гепатите.

~%-33.33333% при портальном циррозе печени.

}